

■ 脳卒中／単盲検RCT

# 電気鍼を先にARで歩行訓練 歩行速度が有意に上乘せ

亜急性期脳卒中40人、Wald検定 $P=.011$

亜急性期脳卒中患者40人を、電気鍼(EA)をAR歩行訓練の前に行う実験群(20人)と、AR歩行訓練のみの対照群(20人)に分けた単盲検RCT。介入期間は4週間、主要評価項目は歩行速度とした。

結果、実験群のほうが歩行速度の改善が有意に大きく(Wald  $\chi^2=6.509$ 、 $P=.011$ )、歩

幅・歩行対称性・下肢FMA・BBS・CCIでも有意差(いずれも $P<.05$ )。歩隔・ケイデンス・関節運動には差がなく、有害事象もなかった。

著者は「電気鍼を先に行うことで運動学習を促す神経調節状態が生まれるのでは」と仮説を示すが、機序の解釈は今後の確認が必要。小規模短期

試験で、効果の持続や再現性は未確認。



亜急性期脳卒中40人のRCTで見えた歩行速度改善の数字

出典 **Am J Phys Med Rehabil** ↗

数字で見る

**40人**  
単盲検RCTの対象

**.011** P値  
歩行速度改善の有意差

**4週間**  
介入期間

■ 介護報酬改定／制度

## 施設入所中は車椅子を借りられない リハ専門職団体が是正要望

リハビリテーション専門職団体協議会が令和9年度介護報酬改定に向けたヒアリングで4項目を提示、うち1つが「施設入所中の車椅子貸与」。現行制度では福祉用具貸与は居宅サービス限定で施設サービスは原則対象外のため、入所時に使っていた車椅子を継続できず、体に合わない備品を使わざるを得ない状況が起きている。

団体は「リハ専門職のアセスメントに基づき自立支援・重度化防止を目的とした車椅子の必要性



がケアプランに明記された場合は、施設入所中でも貸与を可能に」と要望。適切な車椅子は離床支援に加え誤嚥・褥瘡・転倒骨折・再入院の予防にもつながるとする。ヒアリング段階の要望で、改定への反映は今後次第。

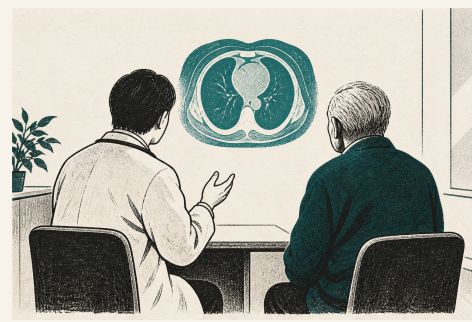
出典 **PT-OT-ST.NET** ↗

■ 医療AI／総説

## 高齢者医療のAI活用を 4領域で整理した総説

多疾患併存・フレイル・サルコペニア・認知機能低下・ポリファーマシーが絡み合う高齢者医療で、AIをどう位置づけるか。東京大学の岡敬之氏による統合的レビューが4領域を整理した。①画像AI(骨・筋量の定量化など整形外科領域)、②予測AI(フレイル・転倒・再入院・要介護化の機械学習予測)、③生成AI(診療記録要約・患者説明支援)、④マルチモーダルAI(複数データ種の統合)。

倫理的課題として、学習データの代表性、年齢



バイアス、判断根拠の説明可能性、認知症患者からの同意取得、デジタルデバイドを挙げる。総説のため個々の技術の有効性データは含まれないが、AI導入の議論を進める上での「論点の地図」として使える一本。

出典 **日本老年医学会雑誌** ↗

短信

〈脳卒中／心理社会〉**身体的依存とレジリエンス**

脳卒中123人。自己効力感が媒介、就労歴と介入群で関係が変化。 出典 **Topics in Stroke Rehabilitation** ↗

〈慢性疼痛／理学療法〉**重症度は転帰の指標にならず**

慢性筋骨格痛169人。基準時重症度で2群、調整後の転帰は同等。 出典 **British Journal of Pain** ↗

〈脳卒中／動作解析〉**マーカーレスで肩代償を定量**

脳卒中25人。動作解析+筋電の指標がFMAと強相関( $\rho=0.93$ )。 出典 **J Electromyogr Kinesiol** ↗

〈医療AI／教育〉**医療情報学修士のAI方針**

米48プログラム調査。学業倫理中心、規制面の記載は少数。 出典 **JAMIA** ↗

〈外来リハ／デジタルヘルス〉**手首センサーの実行可能性**

臨床医17人・患者38人、9か月の概念実証。アドヒアランス68.6%。 出典 **medRxiv** (プレプリント) ↗

〈フレイル／評価尺度〉**多次元フレイル尺度を検証**

MFSの心理測定学的特性を検討する尺度開発研究。 出典 **medRxiv** (プレプリント) ↗

〈作業療法／教育〉**学生1,743人の未来像調査**

日本作業療法士協会がアンケート、将来の作業療法士像を聴取。 出典 **PT-OT-ST.NET** ↗

〈制度／厚労省検討会〉**リハ業務、半数病棟で分担**

厚労省検討会。リハビリ・自立援助を他職種と分担する病棟が半数。 出典 **POST** (リハ職メディア) ↗